

# PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AUDITORÍA MÉDICA

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|                                                                                     | <b>Dra. Maite Vargas</b><br>Elaborado                                               | <b>Dr. Argenis Navas</b><br>Revisado                                                 | <b>Dra. Nieves Navarrete</b><br>Aprobado                                              |
|                                                                                     | Médico general                                                                      | Jefe de auditoría médica                                                             | Gerente médico y de operaciones                                                       |
|                                                                                     | <b>FECHA</b> 27 de octubre del 2025                                                 | <b>FECHA</b> 29 de octubre del 2025                                                  | <b>FECHA</b> 31 de octubre del 2025                                                   |

## 1. OBJETIVO

Evaluar de manera sistemática y objetiva la calidad de la atención médica brindada, verificando el cumplimiento de protocolos, normativas y estándares establecidos, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan a la seguridad del paciente, la eficiencia en la atención médica y el fortalecimiento de la gestión clínica.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para las auditorías médicas realizadas en Metrored, desde la selección de la muestra de auditoría hasta la gestión de la mejora continua.

## 3. DEFINICIONES

**Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluar de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios previamente definidos.

**Evidencia de la auditoría:** Registro, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que sean verificables.

**Mejora continua:** Enfoque sistemático que busca identificar oportunidades para optimizar la calidad de los servicios de salud, aumentando la eficiencia, la seguridad del paciente y la satisfacción tanto de usuarios como del personal.

**Observaciones de auditoría:** Hallazgos negativos, encontrados durante la evaluación frente a los criterios establecidos.

**Recomendaciones de auditoría:** Sugerencias, propuestas o acciones correctivas emitidas por un auditor médico tras evaluar la calidad y pertinencia de la atención médica evaluada.

**Plan de acción:** es una herramienta de gestión que establece las acciones y estrategias necesarias para alcanzar un objetivo específico. Es un documento detallado que define las tareas a realizar, los responsables de cada tarea, los recursos necesarios y los plazos de ejecución.

## 4. RESPONSABLES

### a. Responsable del procedimiento

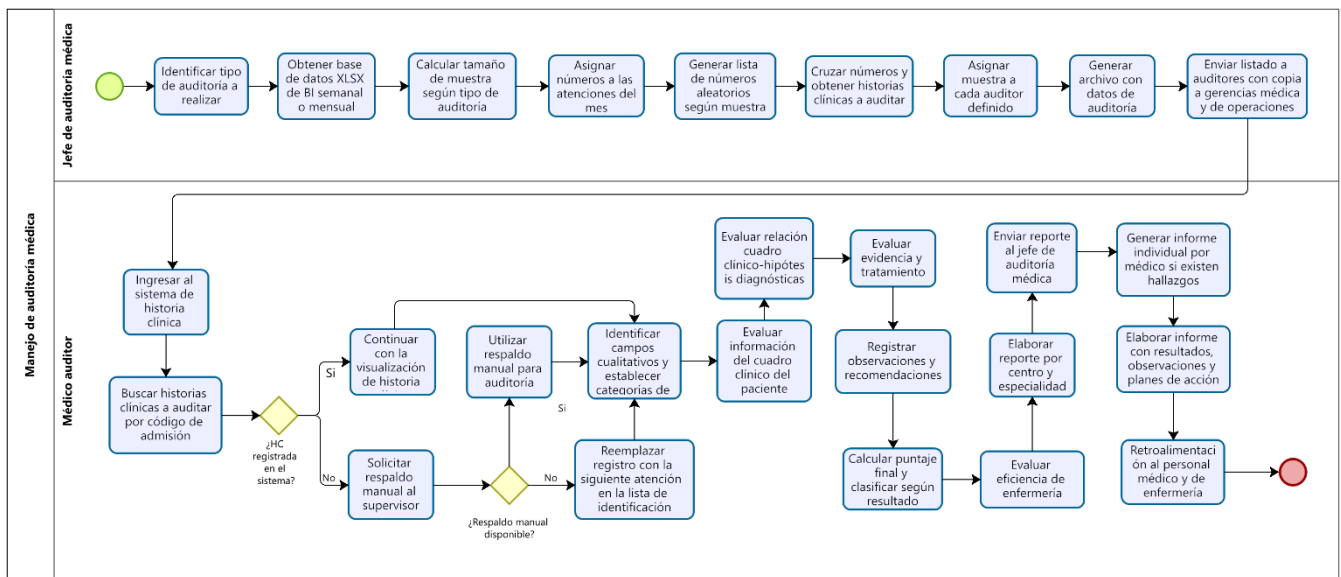
Jefe de auditoría médica  
Médico auditor

### b. Corresponsables de la ejecución del procedimiento

Gerente médico y de operaciones

## 5. FLUJOGRAMA

### 5.1. Manejo de auditoría médica



## 6. DESARROLLO

El jefe de auditoría médica es responsable de planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las auditorías necesarias para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad asistencial, la adherencia a protocolos clínicos y la optimización continua de los procesos de atención médica. Para el logro de estos objetivos de calidad, se han establecido las siguientes modalidades de auditoría:

### 1. Auditoría mensual

Esta modalidad se realiza de manera sistemática y mensual sobre el universo de atenciones en consulta médica del mes anterior. Su objetivo es evaluar la calidad global del registro clínico, la adherencia a guías de práctica clínica y la pertinencia de las decisiones médicas. Se emplea el muestreo estratificado, como práctica estadística.

### 2. Auditoría a nuevos ingresos

Esta modalidad tiene como objetivo acompañar el proceso de inducción y adaptación de los nuevos profesionales médicos a los estándares institucionales. Consiste en la revisión semanal de tres atenciones médicas seleccionadas aleatoriamente durante los primeros tres meses desde su incorporación, permitiendo retroalimentación oportuna y verificación de competencias en el registro clínico y toma de decisiones. Se emplea el muestreo no probabilístico (muestreo discrecional o por juicio).

### 3. Auditoría de caso

Esta modalidad se activa ante situaciones que requieren análisis profundo y específico debido a su impacto en la seguridad del paciente, implicaciones legales, reclamos formales o complejidad clínica particular. Se realiza por solicitud expresa de la Gerencia Médica y de Operaciones, aplicando el Protocolo de Londres adaptado institucionalmente, con el fin de identificar factores contribuyentes, establecer acciones preventivas y fortalecer la cultura de seguridad.

#### 6.1 Definición y asignación de la auditoría

| N° | Responsable              | Descripción                                                                                                                                | Referencia |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Jefe de auditoría médica | Debe identificar y definir el tipo de auditoría a efectuarse.                                                                              |            |
| 2  | Jefe de auditoría médica | Debe obtener la base de datos en archivo con formato XLSX, proporcionada por el área de BI, de forma semanal o mensual, según corresponda. | Anexo 1    |

| N° | Responsable              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referencia               |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3  | Jefe de auditoría médica | <p>Debe Calcular el tamaño de muestra de acuerdo con los parámetros establecidos, según el tipo de auditoría a realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría mensual</li> <li>• Auditoría a nuevos ingresos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anexo 2<br>MTR-GM-MT-009 |
| 4  | Jefe de auditoría médica | Debe asignar números a la base de datos de las atenciones del mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 5  | Jefe de auditoría médica | Debe obtener por cada caso una lista de números aleatorios según el tamaño de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 6  | Jefe de auditoría médica | <p>Debe realizar el cruce entre estos números y obtener el número de historias clínicas a ser auditadas y asignar la muestra por cada auditor definido.</p> <p>El archivo debe contener lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de auditoría</li> <li>• Nombre del profesional</li> <li>• Centro médico</li> <li>• Especialidad</li> <li>• Fecha</li> <li>• Código de admisión</li> </ul> <p>Adicionalmente debe enviar el listado definido a cada de los auditores vía correo electrónico con copia a la gerencia médica y de operaciones.</p> |                          |

## 6.2 Ejecución de Auditoría médica

| N° | Responsable    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referencia               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7  | Médico auditor | Al receptar la solicitud de auditoría médica que corresponda, debe ingresar al sistema de historia clínica electrónica en el módulo "Administración", luego al "Panel de control" y finalmente a "Admisiones históricas".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anexo 3                  |
| 8  | Médico auditor | <p>Debe buscar las historias clínicas a auditar de acuerdo con el código de admisión. A continuación, debe visualizar la historia clínica cargada en el sistema.</p> <p><b>Importante:</b> En caso de que la historia clínica no se encuentre registrada en el sistema electrónico de historias clínicas, se deberá solicitar vía correo electrónico al Supervisor del centro médico el respaldo correspondiente de la historia clínica en formato manual. Si dicho documento no está disponible, se procederá a reemplazar el registro con la siguiente atención que conste en la lista de identificación enviada.</p> |                          |
| 9  | Médico auditor | <p>Debe identificar los campos cualitativos del documento auditado y establecer las categorías de análisis para la generación de reportes posteriores como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de auditoría</li> <li>• Nombre del profesional de servicios médicos</li> <li>• Centro médico</li> <li>• Especialidad</li> <li>• Fecha</li> <li>• Código de admisión</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | Anexo 4<br>MTR-GM-MT-003 |
| 10 | Médico auditor | Debe evaluar cuantitativamente la calidad de la información registrada sobre el cuadro clínico del paciente. Se debe poner énfasis en que la información presente tenga una descripción clara y precisa de los aspectos que necesitan ser revisados por el médico en la anamnesis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anexo 5<br>MTR-GM-MT-004 |

| N° | Responsable    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referencia               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 11 | Médico auditor | Debe evaluar cuantitativamente la relación entre el cuadro clínico presentado y el proceso de generación de hipótesis diagnósticas. Se considerará la presencia de un sustento teórico que guarde concordancia con la información levantada para poder llegar a un diagnóstico correcto.                                                                                                  | Anexo 6<br>MTR-GM-MT-005 |
| 12 | Médico auditor | Debe evaluar cuantitativamente el soporte de evidencia y la correspondencia adecuada entre las hipótesis diagnósticas, la solicitud de exámenes complementarios y el manejo terapéutico del caso, el mismo que debe ser adecuadamente soportado con la evidencia científica.                                                                                                              | Anexo 7<br>MTR-GM-MT-006 |
| 13 | Médico auditor | Debe registrar los datos de tipo cualitativo y las principales observaciones y recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 14 | Médico auditor | <p>Debe calcular el puntaje final de cada área de observación y el puntaje global en base a las ponderaciones asignadas a cada variable, con las fórmulas correspondientes. Esto se hará en puntaje con base 100.</p> <p>Se identifican tres grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥90 Óptimo</li> <li>• Entre 80 a 89 Aceptable</li> <li>• &lt;80 No aceptable</li> </ul> | Anexo 8<br>MTR-GM-MT-007 |
| 15 | Médico auditor | Debe evaluar el trabajo del personal de enfermería en el proceso de toma de signos vitales en los centros médicos, según la Matriz Toma de Signos Vitales. Esto se realizará a través del cálculo de eficiencia en la toma de signos vitales según la fórmula establecida.                                                                                                                | Anexo 9<br>MTR-GM-MT-001 |

| N° | Responsable    | Descripción                                                                                                                                                                                                                  | Referencia               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 16 | Médico auditor | Debe realizar un reporte junto con un informe tanto por centros médicos como por especialidad mismo que debe ser enviado vía correo electrónico al jefe de Auditoría médica con copia a la Gerencia Médica y de Operaciones. | Anexo 10<br>MTR-GM-F-024 |

## 6.3 Retroalimentación y seguimiento

| N° | Responsable    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referencia               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17 | Médico auditor | Se debe generar un informe individual por médico cuando se identifiquen hallazgos, que, por su naturaleza (riesgo clínico, glosa potencial, desviación de guía), requieren retroalimentación o en los casos en los que el índice global sea menor a 80.<br><br><b>Importante:</b> Con la firma de la retroalimentación, el médico adquiere el compromiso de dar cumplimiento inmediato a las observaciones registradas. | Anexo 11<br>MTR-GM-F-023 |
| 18 | Médico auditor | Debe generar un informe con los resultados, observaciones, compromisos y planes de acción adecuados para evidenciar la mejora continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 19 | Médico auditor | Debe realizar la retroalimentación al personal médico y de enfermería de acuerdo con las observaciones encontradas en el proceso de auditoría y con la evidencia adecuada para tratar los temas recurrentes o importantes.                                                                                                                                                                                              |                          |

## 7. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

### a. Indicadores:

- Cumplimiento de calidad en el registro clínico:**

$$\% = \frac{\text{Número de historias clínicas con más del 90\% de cumplimiento}}{\text{Total de historias clínicas auditadas}} \times 100\%$$

- Índice de eficiencia en toma de signos vitales:**

$$\% = \frac{\text{Número de historias clínicas con signos vitales completos}}{\text{Total de historias clínicas auditadas}} \times 100$$

- Pertinencia de exámenes complementarios solicitados:**

$$\% = \frac{\text{Número de historias clínicas con solicitudes pertinentes}}{\text{Total de historias clínicas auditadas}} \times 100\%$$

- Cumplimiento de guías de práctica clínica en diagnóstico y tratamiento:**

$$\% = \frac{\text{Número de historias clínicas con adherencia a guías}}{\text{Total de historias clínicas auditadas}} \times 100\%$$

- Cumplimiento de auditorías médicas por médico auditor:**

$$\% = \frac{\text{Auditorías realizadas}}{\text{Auditorías planificadas}} \times 100\%$$

- Cumplimiento en la retroalimentación y seguimiento de hallazgos de auditoría**

$$\% = \frac{\text{Total de hallazgos con retroalimentación oportuna y documentada}}{\text{Número de hallazgos que requieren retroalimentación}} \times 100\%$$

**Nota:** Solo se consideran los hallazgos que, por su naturaleza (riesgo clínico, glosa potencial, desviación de guía), requieren retroalimentación. O Identificación de un puntaje total por debajo de 80 en la cuantificación global realizada. No todos los hallazgos menores necesitan seguimiento formal.

### b. Meta o rango de aceptación:

- Cumplimiento de calidad en el registro clínico:  $\geq 85\%$
- Índice de eficiencia en toma de signos vitales:  $\geq 90\%$
- Pertinencia de exámenes complementarios:  $> 90\%$
- Cumplimiento de guías de práctica clínica:  $\geq 90\%$
- Cumplimiento de auditorías médicas por médico auditor:  $> 95\%$
- Cumplimiento en retroalimentación y seguimiento:  $\geq 90\%$

c. Frecuencia de medición:

Todos los indicadores son de medición mensual

d. Responsable del indicador:

Jefe de auditoría médica

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

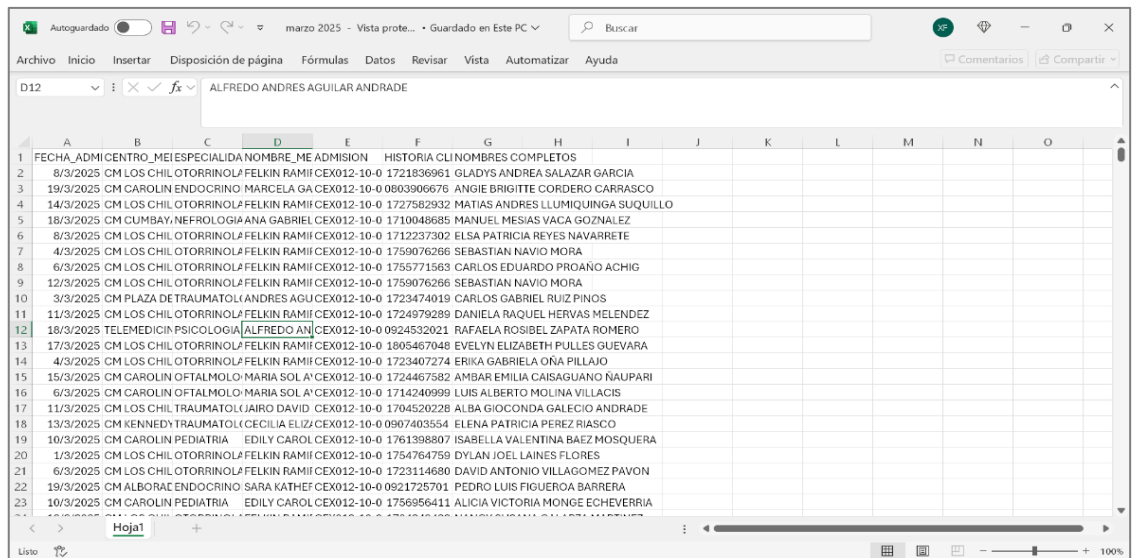
Llanos Zavalaga, Fernando. (2000). Auditoría médica en el primer nivel de atención. *Revista Médica Herediana*, 11(3), 107-112. Recuperado en 25 de abril de 2025, de [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1018-130X2000000300006](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2000000300006)  
Norma técnica de auditoría de la calidad de atención en salud / Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Dirección Ejecutiva de Calidad en Salud -- Lima: Ministerio de Salud, 2005

9. DISTRIBUCIÓN Y ACCESO AUTORIZADO

Gerente médico y de operaciones  
Jefe de auditoría médica  
Médico auditor

10. ANEXOS

Anexo 1. Base de datos de atenciones realizadas



| 1  | FECHA     | ADMI        | CENTRO            | MEI        | ESPECIALIDA | NOMBRE      | ME          | ADMISION   | HISTORIA  | CLIN      | NOMBRES     | COMPLETOS |
|----|-----------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 2  | 8/3/2025  | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1721836961 | GLADYS    | ANDREA    | SALAZAR     | GARCIA    |
| 3  | 19/3/2025 | CM          | CAROLIN           | ENDOCRINO  | MARCELA     | GA          | CEX012-10-0 | 0803906676 | ANGIE     | BRIGITTE  | CORDERO     | CARRASCO  |
| 4  | 14/3/2025 | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1727582932 | MATIAS    | ANDRES    | LLUMIQUINGA | SUQUILLO  |
| 5  | 18/3/2025 | CM          | CUMBAY            | NEFROLOGIA | ANA         | GABRIEL     | CEX012-10-0 | 1710048685 | MANUEL    | MESIAS    | VACA        | GOZNALEZ  |
| 6  | 8/3/2025  | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1712237302 | ELSA      | PATRICIA  | REYES       | NAVARRETE |
| 7  | 4/3/2025  | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1759076266 | SEBASTIAN | NAVIO     | MORA        |           |
| 8  | 6/3/2025  | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1755771563 | CARLOS    | EDUARDO   | PROANO      | ACHIG     |
| 9  | 12/3/2025 | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1759076266 | SEBASTIAN | NAVIO     | MORA        |           |
| 10 | 3/3/2025  | CM          | PLAZA DE TRAUMATO | ANDRES     | AGU         | CEX012-10-0 | 1723474019  | CARLOS     | GABRIEL   | RUIZ      | PIÑOS       |           |
| 11 | 11/3/2025 | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1724979289 | DANIELA   | RAQUEL    | HERVAS      | MELENDEZ  |
| 12 | 18/3/2025 | TELEMEDICIN | PSICOLOGIA        | ALFREDO    | AN          | CEX012-10-0 | 0924532021  | RAFAELA    | ROSIBEL   | ZAPATA    | ROMERO      |           |
| 13 | 17/3/2025 | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1805467048 | EVELYN    | ELIZABETH | PULLES      | GUEVARA   |
| 14 | 4/3/2025  | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1723407274 | ERIKA     | GABRIELA  | ONA         | PILLAJO   |
| 15 | 15/3/2025 | CM          | CAROLIN           | OFTALMOLO  | MARIA       | SOL A       | CEX012-10-0 | 1724467582 | AMBAR     | EMILIA    | CAISAGUANO  | NAUPARI   |
| 16 | 6/3/2025  | CM          | CAROLIN           | OFTALMOLO  | MARIA       | SOL A       | CEX012-10-0 | 1714240999 | LUIS      | ALBERTO   | MOLINA      | VILLACIS  |
| 17 | 11/3/2025 | CM          | LOS CHIL          | TRAUMATOLO | JAIR        | DAVID       | CEX012-10-0 | 1704526028 | ALBA      | GIACONDA  | GALGEO      | ANDRADE   |
| 18 | 13/3/2025 | CM          | KENNEDY           | TRAUMATOLO | CECILIA     | ELIZ        | CEX012-10-0 | 0807403554 | ELENA     | PATRICIA  | PEREZ       | RIASCO    |
| 19 | 10/3/2025 | CM          | CAROLIN           | PEDIATRIA  | EDILY       | CAROL       | CEX012-10-0 | 1761398807 | ISABELLA  | VALENTINA | BAEZ        | MOSQUERA  |
| 20 | 1/3/2025  | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1754764759 | DYLAN     | JOEL      | LAINES      | FLORES    |
| 21 | 6/3/2025  | CM          | LOS CHIL          | OTORRINOL  | FELKIN      | RAMIR       | CEX012-10-0 | 1723114680 | DAVID     | ANTONIO   | VILLAGOMEZ  | PAVON     |
| 22 | 19/3/2025 | CM          | ALBORAC           | ENDOCRINO  | SARA        | KATHEF      | CEX012-10-0 | 0921725701 | PEDRO     | LUIS      | FIGUEROA    | BARREIRA  |
| 23 | 10/3/2025 | CM          | CAROLIN           | PEDIATRIA  | EDILY       | CAROL       | CEX012-10-0 | 1756956411 | ALICIA    | VICTORIA  | MONGE       | ECHVERRIA |

|                                                                                   |                                                                          |                                     |                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AUDITORÍA MÉDICA</b>                  |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-PR-007 |                 |
|                                                                                   |                                                                          |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2               |
|                                                                                   | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 |                                | Página 11 de 18 |

**Anexo 2. Matriz para el cálculo de muestra en auditoría médica MTR-GM-MT-009**

|                                                                                   |                                                                          |                                     |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | <b>MATRIZ PARA EL CÁLCULO DE MUESTRA EN AUDITORÍA MÉDICA</b>             |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-MT-009 |               |
|                                                                                   |                                                                          |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2             |
|                                                                                   | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 |                                | Página 1 de 1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Determinación del tamaño de muestra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1. Calcular el tamaño de muestra total (n) usando la fórmula para poblaciones finitas con: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nivel de confianza: 95%</li> <li>○ Margen de error: 5%</li> <li>○ Proporción esperada: 0.5</li> <li>○ Población total: suma de todas las atenciones médicas del mes anterior</li> </ul>                                                                                          |  |
| 2. Registrar el valor de n como base para la distribución estratificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Clasificación por estratos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1. Agrupar las especialidades médicas en tres estratos según volumen de registros: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Estrato 1: especialidades con más de 3000 registros.</li> <li>○ Estrato 2: entre 1000 y 2999 registros.</li> <li>○ Estrato 3: menos de 1000 registros.</li> </ul>                                                                                                                        |  |
| 2. Registrar el número de especialidades y población total por estrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Asignación proporcional de la muestra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1. Distribuir el tamaño de muestra total (n) proporcionalmente entre los tres estratos: $n_i = \left( \frac{N_i}{N} \right) \cdot n$ <p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_i</math>= población del estrato</li> <li>• <math>N</math>= población total</li> <li>• <math>n_i</math>= muestra asignada al estrato</li> <li>• <math>n</math>= tamaño de la muestra inicial a auditar</li> </ul> |  |
| 2. Ajustar manualmente si es necesario para garantizar al menos una muestra por especialidad, sin exceder el total de n.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Asignación dentro de cada estrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1. Calcular la proporción de cada especialidad dentro de su estrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2. Asignar muestras por especialidad usando: $n_{ij} = \left( \frac{N_{ij}}{N_i} \right) \cdot n_i$ <p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>N_{ij}</math>= población de la especialidad j en el estrato i</li> <li>• <math>n_{ij}</math>= muestra asignada a la especialidad j</li> </ul>                                                                                                       |  |
| 3. Redondear los valores y ajustar para mantener el total de n exacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## Anexo 4. Matriz de datos generales de identificación MTR-GM-MT-003

|                                                                                     |                                                                          |                                  |                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | <b>MATRIZ DE DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN</b>                       |                                  | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-MT-003 |               |
|                                                                                     |                                                                          |                                  | <b>VERSIÓN</b>                 | 1             |
|                                                                                     | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>09 – mayo - 2025 |                                | Página 1 de 1 |

**Objetivo:** Consolidar de forma estructurada la información básica y general de cada historia clínica o caso auditado, con el fin de facilitar la identificación, trazabilidad y análisis del expediente médico dentro del proceso de auditoría.

| CATEGORÍA                           | VARIABLE                          | DESCRIPCIÓN            | VALORES              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.Datos generales de identificación | Datos generales de identificación | Número de evaluación   | Variable descriptiva |
|                                     |                                   | Nombre del profesional |                      |
|                                     |                                   | Centro médico          |                      |
|                                     |                                   | Especialidad           |                      |
|                                     |                                   | Fecha                  |                      |
|                                     |                                   | Nº de Historia clínica |                      |

|                                                                                   |                                                                          |                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AUDITORÍA MÉDICA</b>                  |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-PR-007 |
|                                                                                   |                                                                          |                                     | <b>VERSIÓN</b> 2               |
|                                                                                   | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 | Página 13 de 18                |

Anexo 5. Matriz definición variables cuantitativas MTR-GM-MT-004

|                                                                                   |                                                                          |                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>MATRIZ DEFINICIÓN VARIABLES DE REGISTRO</b>                           |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-MT-004 |
|                                                                                   |                                                                          |                                     | <b>VERSIÓN</b> 2               |
|                                                                                   | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 | Página 1 de 1                  |

**Objetivo:**

Identificar de forma clara al paciente y al profesional de salud, así como documentar detalladamente la atención médica brindada.

| CATEGORÍA   | VARIABLE             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                   | VALORES                                                                                  |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Registro | Datos                | Se escribe los datos de consulta según la especialidad respectiva                                                                                                                                             | 1: Datos presentes y correctos.<br><br>0: Datos incompletos, incorrectos o inexistentes. |
|             | Signos               | Signos vitales registrados completos y adecuados para la edad                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|             | APP                  | Presencia de registro de antecedentes personales relevantes                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|             | APF                  | Presencia de registro, tanto positivo como negativo de antecedentes familiares relevantes                                                                                                                     |                                                                                          |
|             | Alergias             | Presencia de registro de antecedentes de alergias                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|             | MC                   | Registro del motivo por el que el paciente acude a pedir atención médica                                                                                                                                      |                                                                                          |
|             | EA                   | Descripción de la evaluación y detalles de los síntomas y/o signos descritos en el motivo de consulta y los hallazgos en el interrogatorio                                                                    |                                                                                          |
|             |                      | Mención de signos o síntomas negativos importantes para el diagnóstico diferencial                                                                                                                            |                                                                                          |
|             | RAS                  | Describe signos y síntomas extras al motivo de consulta y forman parte importante del diagnóstico                                                                                                             |                                                                                          |
|             | EF                   | Descripción clara y específica de hallazgos en el examen físico registro de datos negativos importantes para el diagnóstico diferencial                                                                       |                                                                                          |
|             | Historia consistente | Se evalúa la estructura global de la redacción de la historia clínica buscando la consistencia interna                                                                                                        |                                                                                          |
|             | Riesgo Legal         | Se evalúa si la información presente en la historia, en caso de presentarse alguna queja, contenga vacíos que puedan presentar riesgo dejando espacio libre para especulaciones o que no evidencie lo actuado |                                                                                          |

|                                                                                   |                                                         |                                     |                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AUDITORÍA MÉDICA</b> |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-PR-007 |                 |
|                                                                                   |                                                         |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2               |
| Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/>          |                                                         | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 |                                | Página 14 de 18 |

Anexo 6. Matriz definición variables evaluación clínica MTR-GM-MT-005

|                                                                                   |                                                       |                                     |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | <b>MATRIZ DEFINICIÓN VARIABLES EVALUACIÓN CLÍNICA</b> |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-MT-005 |               |
|                                                                                   |                                                       |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2             |
| Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/>          |                                                       | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 |                                | Página 1 de 1 |

**Objetivo:**

Busca medir la calidad del razonamiento clínico y la capacidad del profesional para formular una hipótesis diagnóstica precisa y relevante. Esto es crucial para un diagnóstico correcto y un tratamiento efectivo del paciente.

| CATEGORÍA             | VARIABLE              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            | VALORES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Evaluación Clínica | Hipótesis Diagnóstica | Se analiza la hipótesis diagnóstica más probable, considerando de manera integral la historia clínica, los factores de riesgo y la situación del contexto del paciente | 1: Se analiza la hipótesis diagnóstica más probable, considerando de manera integral la historia clínica, los factores de riesgo y la situación del contexto del paciente.<br><br>0: la hipótesis señalada no está entre las primeras 3 opciones o tiene más de una hipótesis fuera de contexto. |

Anexo 7. Matriz de definición variables indicaciones y terapéuticas MTR-GM-MT-006

|                                                                                     |                                                                   |                                     |                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | <b>MATRIZ DE DEFINICIÓN VARIABLES INDICACIONES Y TERAPEUTICAS</b> |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-MT-006 |               |
|                                                                                     |                                                                   |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2             |
| Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/>            |                                                                   | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 |                                | Página 1 de 1 |

**Objetivo:**

Evaluar la calidad, pertinencia y fundamentación científica de las decisiones terapéuticas registradas en la historia clínica, incluyendo exámenes de laboratorio e imagen, prescripción de medicamentos, indicaciones generales y recomendaciones de hábitos saludables.

| CATEGORÍA                     | VARIABLE                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                    | VALORES                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Indicaciones y terapéutica | LABORATORIO                                 | Los exámenes prescritos se soportan tanto en evidencia clínica como científica                                                                 | 1: Todo lo prescrito está soportado adecuadamente por la historia clínica y por la evidencia científica.<br><br>0: La mayoría de lo prescrito carece de evidencia, existiendo disponibilidad de esta. |
|                               | IMAGEN                                      | Los exámenes prescritos se soportan tanto en evidencia clínica como científica                                                                 | 1: Todo lo prescrito está soportado adecuadamente por la historia clínica y por la evidencia científica.<br><br>0: La mayoría de lo prescrito carece de evidencia, existiendo disponibilidad de esta. |
|                               | PRESCRIPCIÓN                                | La decisión de la prescripción terapéutica es adecuada y está soportada en la evidencia científica.                                            | 1: Todo lo prescrito está soportado adecuadamente por la historia clínica y por la evidencia científica.<br><br>0: La mayoría de lo prescrito carece de evidencia, existiendo disponibilidad de esta. |
|                               | INDICACIONES COMPLETAS                      | Indicaciones completas y claras sin espacios de confusión para el paciente, dosificación, horarios, tiempo de tratamiento                      | 1: Todo lo prescrito está soportado adecuadamente por la historia clínica y por la evidencia científica.<br><br>0: La mayoría de lo prescrito carece de evidencia, existiendo disponibilidad de esta. |
|                               | PRESCRIPCIÓN DE HáBITOS Y ASESORÍA EN SALUD | La prescripción cuenta con recomendaciones de hábitos saludables y no farmacológicos, así como aspectos de prevención y promoción de la salud. | 1: Se realizan prescripciones no farmacológicas necesarias para la mejoría.<br><br>0: No se realizan prescripciones no farmacológicas.                                                                |

|                                                                                   |                                                                          |                                     |                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AUDITORÍA MÉDICA</b>                  |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-PR-007 |   |
|                                                                                   |                                                                          |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2 |
|                                                                                   | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 | Página 15 de 18                |   |

Anexo 8. Matriz cálculo del puntaje MTR-GM-MT-007

|                                                                                   |                                                                          |                                     |                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | <b>MATRIZ CÁLCULO DEL PUNTAJE</b>                                        |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-MT-007 |   |
|                                                                                   |                                                                          |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2 |
|                                                                                   | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 | Página 1 de 1                  |   |

**Objetivo:**

El objetivo de este sistema de puntaje es evaluar la calidad de la atención médica registrada en la historia clínica, mediante un análisis cuantitativo de tres áreas clave: el registro clínico, la evaluación del paciente y las indicaciones terapéuticas. Esto permite identificar fortalezas y debilidades en la atención, mejorar la calidad del servicio y garantizar el cumplimiento de criterios clínicos, técnicos y legales.

| CATEGORÍA  | VARIABLE                   | DESCRIPCIÓN                                                                                  | CÁLCULO                                                                                                     |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PUNTAJE | CALIDAD DEL REGISTRO       | (40% POR PROMEDIO DE LOS CAMPOS DE REGISTRO) + (30% DE CONSISTENCIA) + (30% DE RIESGO LEGAL) | (APP + APF + ALERGIAS + MC + EA + SIG NEG + RAS + EF) * 4/8) + (HISTORIA CONSISTENTE *3 + (RIESGO LEGAL *3) |
|            | EVALUACIÓN CLÍNICA         | PROMEDIO SIMPLE DE LOS CAMPOS DE EVALUACIÓN CLÍNICA                                          | EVALUACIÓN CLÍNICA *10                                                                                      |
|            | INDICACIONES Y TERAPÉUTICA | PROMEDIO SIMPLE DE LOS CAMPOS DE TERAPÉUTICA                                                 | LABORATORIO *3 + IMAGEN *3 + PRESCRIPCIÓN *2 + INDICACIONES COMPLETAS *1 + PRESCRIPCIÓN DE HÁBITOS *1       |
|            | GLOBAL                     | PROMEDIO SIMPLE DEL TOTAL DE CALIDAD DE REGISTRO, EVALUACIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA           | CALIDAD DE REGISTRO *0,4 + EVALUACIÓN CLÍNICA *0,2 + TERAPÉUTICA*04                                         |

Anexo 9. Matriz de toma de signos vitales MTR-GM-MT-001

|                                                                                     |                                                                          |                                     |                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | <b>MATRIZ TOMA DE SIGNOS VITALES</b>                                     |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-MT-001 |   |
|                                                                                     |                                                                          |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 1 |
|                                                                                     | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>30 - octubre - 2024 | Página 1 de 1                  |   |

**Objetivo:** Identificar las especialidades que requieren la toma de signos vitales y los tipos específicos de signos vitales necesarios. Esto permitirá brindar una atención óptima al paciente y asegurar un flujo adecuado hacia la atención médica.

| ESPECIALIDAD                    | TOMA EN CONSULTORIO | TOMA EN ENFERMERÍA (SV) | ANTROPOMETRÍA |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Alergología                     |                     | X                       |               |
| Cardiología                     | X                   |                         | X             |
| Cirugía General                 |                     | X                       |               |
| Cirugía Vascular                |                     | X                       |               |
| Deportología                    | X                   |                         | X             |
| Dermatología                    |                     | X                       |               |
| Endocrinología                  |                     | X                       | X             |
| Gastroenterología               |                     | X                       | X             |
| Ginecología                     |                     | X                       | X             |
| Mastología / Cirugía Oncológica |                     | X                       |               |
| Medicina General                | X                   |                         | X             |
| Medicina Interna                | X                   |                         | X             |
| Nefrología                      | X                   |                         | X             |
| Neumología                      |                     | X                       | X             |
| Neurología                      |                     | X                       |               |
| Nutrición                       | X                   |                         | X             |
| Oftalmología                    |                     | X                       |               |
| Otorrinolaringología            |                     | X                       |               |
| Pediatría                       | X                   |                         | X             |
| Proctología                     |                     | X                       |               |
| Reumatología                    |                     | X                       | X             |
| Traumatología                   |                     | X                       |               |
| Urología                        |                     | X                       |               |

|                                                                                   |                                                                          |                                     |                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AUDITORÍA MÉDICA</b>                  |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-PR-007 |                 |
|                                                                                   |                                                                          |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2               |
|                                                                                   | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 |                                | Página 16 de 18 |

Anexo 10. Formato de informe para auditoría interna MTR-CSP-F-016

|                                                                                   |                                                                          |                              |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>                                      |                              | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-CSP-F-016 |               |
|                                                                                   |                                                                          |                              | <b>VERSIÓN</b>                 | 1             |
|                                                                                   | Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/> | <b>FECHA</b><br>09-mayo-2025 |                                | Página 1 de 2 |

**1. DATOS GENERALES DEL INFORME DE AUDITORÍA**

| AUDITOR                                                                                     | FECHA                                                | ÁREA AUDITADA                                                                                           | OBJETIVO                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del médico auditor encargado del proceso de retroalimentación con el médico auditado | Fecha en la que se lleva a cabo la retroalimentación | Atención médica ambulatoria brindada al paciente en el Centro Médico _____ en la especialidad de _____. | Evaluar la calidad y seguridad de la atención médica proporcionada, identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de los estándares y normativas vigentes. |

**2. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES**

| NO CONFORMIDADES DETECTADAS |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| N°                          | Descripción de las no conformidades detectadas |
| 1.                          |                                                |
| 2.                          |                                                |
|                             |                                                |
|                             |                                                |

**3. RECOMENDACIONES**

| RECOMENDACIONES |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| N°              | Descripción de las recomendaciones ofrecidas |
| 1.              |                                              |
| 2.              |                                              |
|                 |                                              |
|                 |                                              |

**4. FIRMAS**

| JEFE DE AUDITORÍA MÉDICA<br>(Nombre, fecha y firma) | MÉDICO AUDITOR<br>(Nombre y firma) | AUDITADO<br>(Nombre y firma) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                     |                                    |                              |

|                                                                                   |                                                         |                                     |                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AUDITORÍA MÉDICA</b> |                                     | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-PR-007 |                 |
|                                                                                   |                                                         |                                     | <b>VERSIÓN</b>                 | 2               |
| Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/>          |                                                         | <b>FECHA</b><br>31 - octubre - 2025 |                                | Página 17 de 18 |

**Anexo 11. Formato de informe para auditoría de caso médico MTR-GM-F-023**

|                                                                                   |                                            |                              |                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | <b>INFORME DE AUDITORÍA DE CASO MÉDICO</b> |                              | <b>CÓDIGO</b><br>MTR-GM-F-023 |               |
|                                                                                   |                                            |                              | <b>VERSIÓN</b>                | 1             |
| Revisión <input type="radio"/> Vigencia <input checked="" type="radio"/>          |                                            | <b>FECHA</b><br>09-mayo-2025 |                               | Página 1 de 2 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Auditoría N°</b>        |  |
| <b>Nombre del auditado</b> |  |
| <b>Nombre del auditor</b>  |  |
| <b>Asunto</b>              |  |
| <b>Fecha del informe</b>   |  |

**1. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD**

[Se deben detallar los hallazgos observados en la atención ambulatoria que dan origen a la auditoría médica, que incluye: historia clínica, órdenes de exámenes de laboratorio, órdenes de estudios de imagen, solicitud de procedimientos, planteamiento diagnóstico y receta o prescripción médica.]

**2. ORIGEN DE LA AUDITORÍA**

[Se describe a detalle el error cometido por el profesional de la salud en el documento que originó la realización de la auditoría.]

**3. TIPO DE AUDITORÍA**

[Auditoría de caso.]

**4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

[Se describe el caso clínico que se está evaluando, con fechas de atención, y Centro Médico correspondiente. Se hará referencia a la normativa interna vigente de acuerdo con lo estipulado en el Protocolo de Auditoría Médica.]

**5. INFORMACIÓN CLÍNICA**

[Se detalla la información concerniente a la prestación ambulatoria dada al usuario en base a la historia clínica, registros asistenciales y los informes del personal asistencial o administrativo que participó en la atención del paciente.]

**6. OBSERVACIONES**

[Se analizan los actos asistenciales en sus componentes de evaluación médica, diagnóstico, terapéutica, evolución e intervenciones y otros aspectos relacionados con la atención del paciente, en función de la información que sustente el mejor proceder según los conocimientos científicos, el avance tecnológico disponible y las conductas éticas recomendadas. La observación resultante debe ser producto de la interrelación de la condición, criterio, causa y efecto.]

11. CAMBIOS Y ESTADO DE REVISIÓN

| N°<br>Versión | FECHA<br>DE CAMBIO | CAPÍTULO | PÁGINA | PÁRRAFO ANTERIOR | RESPONSABLE DEL<br>CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO     |
|---------------|--------------------|----------|--------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2             | 31/10/2025         | N/A      | N/A    | N/A              | Dra. Maite Vargas         | Cambios en el procedimiento. |
|               |                    |          |        |                  |                           |                              |
|               |                    |          |        |                  |                           |                              |
|               |                    |          |        |                  |                           |                              |